THORAX · TH-01

Nodule pulmonaire fortuit · Fleischner

Fleischner Society 2017
scanner hors dépistage · adulte ≥ 35 ans

Champ d'application : nodule découvert fortuitement au scanner chez l'adulte **≥ 35 ans**. Non applicable au **dépistage** (voir TH-02), aux patients avec **cancer connu** ou **immunodéprimés**. Mesure : moyenne du grand et du petit axe sur la même coupe, arrondie au mm ; volumétrie possible.

NODULE SOLIDE

TAILLE	UNIQUE · BAS RISQUE	UNIQUE · HAUT RISQUE	MULTIPLES · BAS RISQUE	MULTIPLES · HAUT RISQUE
< 6 mm < 100 mm³	Pas de suivi	Scanner à 12 mois optionnel	Pas de suivi	Scanner à 12 mois optionnel
6–8 mm 100–250 mm³	Scanner à 6–12 mois, puis envisager à 18–24 mois	Scanner à 6–12 mois, puis à 18–24 mois	Scanner à 3–6 mois, puis envisager à 18–24 mois	Scanner à 3–6 mois, puis à 18–24 mois
> 8 mm > 250 mm³	Envisager un scanner à 3 mois, une TEP-TDM ou un prélèvement		Scanner à 3–6 mois, puis envisager à 18–24 mois	

NODULE SUBSOLIDE

TYPE	< 6 MM	≥ 6 MM
Verre dépoli pur, unique	Pas de suivi	Scanner à 6–12 mois ; si persistant, scanner tous les 2 ans jusqu'à 5 ans
Partiellement solide, unique	Pas de suivi	Scanner à 3–6 mois ; si persistant et composante solide < 6 mm, scanner annuel pendant 5 ans. **Composante solide ≥ 6 mm : très suspect**
Multiples	Scanner à 3–6 mois ; si stable, envisager à 2 et 4 ans	Scanner à 3–6 mois, puis selon le nodule le plus suspect

Cancer indolent : un nodule subsolide persistant ou à croissance lente (et les kystes atypiques) correspond souvent à une forme **indolente de cancer du poumon**. Nouveau critère ACR Appropriateness Criteria « Indolent Lung Cancer » (2026) : décision en **staff multidisciplinaire** ; si surveillance choisie plutôt qu'intervention, son seul objectif est de détecter les changements qui modifieraient la conduite (croissance de la composante solide…) ; si traitement décidé, le bilan diagnostique et la biopsie ne font pas partie de la surveillance (voir TH-02).

ESTIMER LE RISQUE

Haut risque (> 5 %)

- Tabagisme important, âge avancé, exposition (amiante, radon, uranium), antécédent familial
- Contours spiculés, localisation lobaire supérieure
- Emphysème, fibrose
- Calculateurs utiles : Brock (PanCan), Mayo

Aspects rassurants

- Calcifications bénignes (centrale, lamellaire, pop-corn, diffuse)
- Graisse intranodulaire (hamartome)
- **Nodule périscissural ou juxtapleural typique** (triangulaire, lentiforme, contours lisses, < 10 mm) : ganglion intrapulmonaire, pas de suivi
- Stabilité ≥ 2 ans pour un solide ; ≥ 5 ans pour un subsolide

PIÈGES

Coupes fines
≤ 1,5 mm (idéalement 1 mm) pour caractériser et mesurer

Croissance
< 2 mm : peu fiable en mesure linéaire ; préférer la volumétrie sur le même logiciel

Subsolide
un nodule subsolide peut régresser (inflammatoire) : contrôle avant toute décision

Contexte
infection récente, jeune âge, cancer connu : ne pas appliquer ces règles

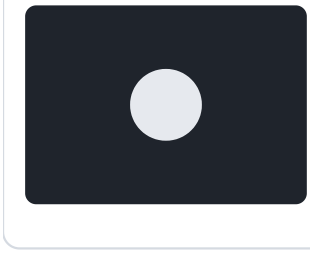
THORAX · TH-01

Nodule pulmonaire fortuit · Fleischner (suite)

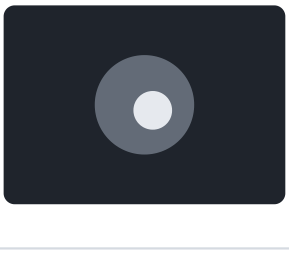
Fleischner Society 2017
scanner hors dépistage · adulte ≥ 35 ans

ATLAS VISUEL

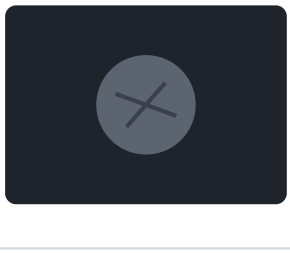
Types de nodules et mesure



Solide
masque le parenchyme



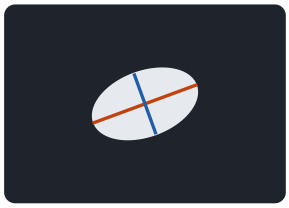
Partiellement solide
mesurer la composante solide



Verre dépoli pur
vaisseaux visibles au travers



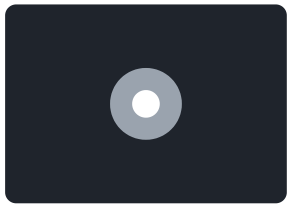
Périscissural
triangulaire, < 10 mm : bénin



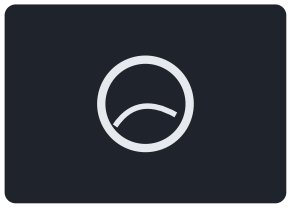
Mesure
(grand + petit axe) / 2



Spiculé
haut risque



Calcification centrale
bénin (granulome)



Kyste atypique
paroi épaisse ou cloisons (Lung-RADS)

Schémas simplifiés, non à l'échelle · fenêtre parenchymateuse

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Recommandations Fleischner
Radiopaedia · tableaux
radiopaedia.org/articles/fleischner-society-pulm

Nodule partiellement solide
Radiopaedia · mesure, évolution
radiopaedia.org/articles/part-solid-lung-nodule-

Nodule périscissural typique (cas)
Radiopaedia · ganglion intrapulmonaire
radiopaedia.org/cases/typical-perifissural-nodul

Nodule en verre dépoli pur
Radiopaedia · conduite
radiopaedia.org/articles/pure-ground-glass-nodul

Calculateur de Brock (PanCan)
Brock University · risque de malignité
brocku.ca/lung-cancer-screening-and-risk-predict

Sources : MacMahon et al., Radiology 2017 – pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2017161659 · Radiopaedia – Fleischner 2017 – radiopaedia.org/articles/fleischner-society-pulmonary-nodule... · ACR AC Indolent Lung Cancer 2026 (PubMed) – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42573542/